Псориаз и его влияние на организм человека

Хубиева Динара Руслановна,
студент, Северо-Кавказская Государственная Академия
Медицинский институт
E-mail: dinara2502@bk.ru

Хубиева Эльмира Руслановна,
студент, Северо-Кавказская Государственная Академия
Медицинский институт
E-mail: elmira2106@bk.ru

Псориаз – это хроническое заболевание, которое поражает ногти, суставы, кожу и даже внутренние органы. Проявляется данное заболевание зудом и наличием высыпаний, которые в дальнейшем сливаются в крупные бляшки.
Заболевание протекает длительно, в этом случае оно часто приводит к длительной потере трудоспособности, нарушает социальную адаптацию пациентов. Рассматриваемые в данной задаче заболевания чрезвычайно разнообразны по медицинским проявлениям, что может затруднить диагностику. Все вышесказанное, без исключения, подтверждает необходимость исследования данной патологии врачами разной квалификации.
Цель исследования заключается в том, чтобы раскрыть значение данного заболевания, распространенность среди населения детского возраста, а также уделили внимание обширной клинике данного недуга и соответственно методам лечения и профилактики.
Задачей данной работы является выявление и определение какой из этиологических факторов является наиболее значимым в формировании высыпаний, отечности и сильного зуда.
Основное содержание исследования составляет анализ псориаза и его влияния на организм человека.
Достигнутые результаты состоят в том, что мы раскрыли важность данного заболевания и его распространенность.

Ключевые слова: псориаз, иммунная система, заболевание, причины, прогноз, летальность и лечение.

Введение

Псориаз–это хроническое, воспалительное заболевание с преобладанием поражения кожи и суставов. Кроме физиологических нюансов болезни, чешуйчатый лишай влияет широкое чувственное и психосоциальное влияние на больных, воздействуя на социальные и межличностные взаимоотношения. Как показывает статистика, псориаз диагностируется у 2–4% населения нашей планеты, это 250 млн человек. Чаще от симптомов псориаза страдают жители холодных и умеренных климатических зон, реже – тропических. Азиаты и африканцы менее подвержены развитию патологии по сравнению с американцами и европейцами. В сельской местности люди болеют псориазом в 2 раз реже, чем в городах. [1]

Цель

Выявить причины, вызывающие данную болезнь, раскрыть значение данного заболевания, распространенность среди населения детского возраста, а также уделили внимание обширной клинике данного недуга и соответственно методам лечения и профилактики.

Материалы исследования

Анализ статистики кожно-венерологических диспансеров, изучение статей, исследований и медицинских пособий на данную тему.

Патогенез

Точный патогенез и относительная важность генетических факторов и факторов окружающей среды до сих пор неизвестны. Семейные исследования, эпидемиологические исследования и изучение человеческого лейкоцитарного антигена позволяют предположить, что псориаз имеет генетические корни. Исследователи обнаружили значительно более высокую, чем обычно, заболеваемость некоторыми лейкоцитарными антигенами в семьях с псориазом, что свидетельствует о возможном нарушении иммунитета. Распространенность псориаза выше среди родственников пациентов с псориазом первой и второй степени родства, чем среди населения в целом [4, стр. 48–56].

Нормальным клеткам кожи требуется 14 дней, чтобы переместиться из базального слоя в роговой, где после 14 дней нормального износа они отслаиваются. Жизненный цикл нормальной клетки кожи составляет 28 дней, в то время как у клеток

кожи, пораженных псориазом, всего 4 дня. Этот значительно сокращенный цикл не позволяет клетке созреть. В результате роговой слой становится толстым и шелушащимся, что приводит к основным проявлениям псориаза.

Факторы риска и триггеры

Сообщалось, что возникновение псориаза может быть вызвано различными местными и системными факторами, такими как лекарственные препараты, такие как нестероидные противовоспалительные препараты, противомалярийные препараты, системные кортикостероиды, беременность, прием прогестерон-содержащих оральных контрацептивов и стрептококковые инфекции (особенно при каплевидном псориазе) [2,7 стр.27–31].

Травма может вызвать изоморфный эффект, при котором на месте повреждения развиваются повреждения. Инфекции, особенно вызванные бета-гемолитическими стрептококками, могут вызвать появление каплевидных поражений. К другим провоцирующим факторам относятся эндокринные изменения, климат (холодная погода, как правило, усугубляет псориаз) и эмоциональный стресс [7, 14–17].

Диета и правильное питание

Пациентам с псориазом следует ограничить потребление насыщенных жирных кислот и заменить их на омега-3, которые обладают противовоспалительным действием. В диетотерапии псориаза чрезвычайно важно использование антиоксидантов, таких как витамины А, С и Е, каротиноиды, флавоноиды и селен. Также рекомендуется принимать добавки с витамином D. Многие исследователи предполагают, что альтернативные диеты положительно влияют на течение псориаза. К ним относятся безглютеновая диета, вегетарианская диета и средиземноморская диета. Диетотерапия пациентов с псориазом также должна быть адаптирована к фармакологическому лечению. Например, пациентам, принимающим метотрексат, назначается прием добавок фолиевой кислоты [8,9].

Причины: предрасполагающие условия также главные предпосылки болезни псориазом имеют все шансы являться: Травматические поражения кожи, также ожоги, укусы насекомых, татуировки. Психические предпосылки псориаза. Это в первую очередь стресс. Симптомы и признаки псориаза могут колебаться от человека к человеку. Общие симптомы и признаки содержат в себе: красные пятна кожи, покрытые толстыми серебристыми чешуйками; сухая, потрескавшаяся кожа, которая может кровоточить или чесаться; опухшие и негнущиеся суставы [2]. Считается, что псориаз является проблема иммунной системы, что вынуждает кожу восстанавливаться стремительнее, чем нужно. При наиболее популярном виде псориаза, известном как псориаз с бляшками, данный стремительный оборот клеток приводит к формированию чешуек и красных пятен.

Совершенно не понятно, что непосредственно порождает перебои в работе иммунной системы. Ученые считают, что и генетика, и факторы окружающей среды играют определенную роль. Данное положение никак не заразно.

Лабораторно-клинические исследования

Лабораторная диагностика псориаза, первостепенно, базируется на показателях крови. Врач-дерматовенеролог определяет ряд изучений, согласно которым во последующем выполняется диагностика.

Основные анализы:

– *общий клинический анализ.* С целью начального этапа заболевания патологические перемены состава крови согласно медицинским признакам никак не характерны. В острой фазе либо во тяжелой также средней стадии формирования болезни, выражаются свойства присутствия воспалительного процесса: болезнь (повышение количества лейкоцитов), увеличение быстроты оседания эритроцитов. Кровь на анализ берут с безымянного пальца.
– *биохимия крови.* Согласно итогам, в главную очередь, оцениваются печеночные характеристики. Более конкретные результаты изучения прослеживаются во повторный промежуток псориаза. Кровь берется из вены.

При тяжелом обострении болезни производится чистка крови с помощью специальных медицинских методик: плазмаферез, гемосорбция, лазерная чистка, аутогемотерапия, УФО.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику псориаза следует проводить с папулезными высыпаниями при сифилисе, красным плоским лишаем, себорейной экземой, атопическим дерматитом, розовым лишаем, красным волосяным отрубевидным, пеленочным дерматитом [2, стр. 8].

Лечение: в связи с серьезностью заболевания может быть начата надлежащая терапия. Лечение псориаза ориентировано для того, чтобы прекратить стремительное увеличение клеток кожи, а также убрать чешуйки. Способы лечения, которые вы применяете, находятся в зависимости от того, в какой степени основателен псориаз, также в какой степени он реагирует на предшествующую терапию. Вероятно, вам потребуется попытаться разнообразить медицинские препараты, либо комбинировать способы лечения, чтобы найти подход, который поможет вам. Виды содержат крема, также мази (районное лечение), светолечение, либо инъективные медицинские препараты. Но, как правило, заболевание может вернуться.

Особенности псориаза у детей

Частота встречаемости псориаза у детей составляет 0,5–2%, и по распространенности хронических дерматозов в педиатрической популяции псориаз занимает второе место после атопического дерматита. Каждый год диагноз «псориаз» устанавли-

вается в среднем у 20 тыс. детей младше 10 лет, при этом тенденция к увеличению заболеваемости в последние годы сохраняется [8, стр. 17].

Диагностика псориаза у детей в ряде случаев остается трудной задачей для врача. У детей, у которых был зарегистрирован псориаз, почти всегда имеются генетический фактор, и один из близких родственников. У детей локализация высыпаний располагается чаще на лице, складках кожи. Псориаз с бляшками у детей развивается редко, в основном это псориаз с дерматитом.

В педиатрической статистике чаще наблюдаются линейный и фолликулярный псориазы, а также пустулезный. Псориаз детского возраста не имеет четко выделенной терапии лечения, является заболеванием, которое трудно поддается лечению. Подходы к лечению являются схожими с таковыми у взрослых, но многие препараты, которые применяются у взрослых являются небезопасными для детей. Под нашим наблюдением находились 7 детей с псориазом в возрасте от 1 года до 15 лет. Из 15 детей мальчиков было 5, а девочек 2. Исходя из данной статистики можем сделать вывод, что псориаз среди детей встречается чаще у мальчиков. Мы выяснили из анамнеза заболевания, что локализируются высыпания чаще на коже лица, ушных раковинах, складок, чаще у детей младшего возраста. У подростков распространен псориаз с бляшками.

Псориаз волосистой части головы установлен у 79% детей, у 21% из них – в основном на коже лица и тела.

Профилактика: Профилактика обострений псориаза сводится к предупреждению стрессов, простудных заболеваний, санации хронических очагов инфекции в организме. Диспансерное наблюдение больных псориазом проводится специалистами дерматовенерологами в условиях кожно-венерологических диспансеров.

Выводы

Многочисленные больные с псориазом обращаются за первичным обследованием, а также за лечением к врачам. Определение псориаза, но кроме того сопутствующих ему медицинских, а также психиатрических болезней станет содействовать оперативной диагностике и соответствующему лечению с поддержкой результативных также не опасных местных способов лечения и иных медицинских также психологических вмешательств, в случае если такое необходимо. Наиболее серьезные и рефрактерные случаи могут требовать назначения к дерматологу с целью последующего обследования и вероятной системной терапии.

Литература

1. Химкина Л.Н. Особенности течения псориаза у детей //Вести. дерматол.-1986.- № 6.-С.62–66.
2. Химкина Л.Н. Особенности течения псориаза у детей //Вести. дерматол.-1986.- № 6.-С.62–66.3. Репарация ДНК у больных псориазом в процессе терапии /А.Ю. Прохоров, В.Н.
3. Мордовцев, Г.Н. Львова, В.В. Чехова //Веста, дерматол.-1991.-№ 1-С.4–6.
4. Псориаз: электронно-микроскопические, вирусологические, молекулярнобиологические исследования /В.Н. Мордовцев, И.В. Старков, Е.Р. Забаровский и др. //Вести, дерматол.-1987.-№ 7.-С.4–10.
5. Ваисов А.Ш., Рахметов А.Б., Расулева Н.Р. Сандиммун в лечении тяжелых форм псориаза //Веста. дерматол.-1998.-№ 6.-С. ЗЗ-34.
6. Беляев Г.М. Лечение и профилактика обострений псориаза с учетом результатов изучения функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы и половых желез: Автореф. дис. .д-ра мед. наук.-М., 1984.-32с.
7. Актуальные вопросы иммунологии в дерматологии /Н.М. Мазина, В.В. Владимиров, О.Н. Курьянова, М.Б. Москаленко //Вести. дерматол.-1993.-№ 2.-С.20–25.
8. Адаменко Г.П., Козин В.М. Нарушения в системе взаимодействия поли- и мононуклеарных фагоцитов крови больных псориазом и экземой //Патогенез и терапия кожных и венерических заболеваний: Тез. докл. II съезда дерматологов и венерологов РБ.-Минск, 1992.-С.75
9. Андреев С.В., Семенов Б.Н. Значение кожи в механизме действия лечебных сред на организм больного //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры, 1988.-№ 5.-С.59–63.
10. Ваисов А.Ш., Рахметов А.Б., Расулева Н.Р. Сандиммун в лечении тяжелых форм псориаза //Веста. дерматол.-1998.-№ 6.-С. ЗЗ-34.

PSORIASIS AND ITS EFFECT ON THE HUMAN BODY

Khubieva D.R., Khubieva E.R.
North Caucasus State Academy Medical Institute

Psoriasis is a chronic disease that affects nails, joints, skin and even internal organs. This disease manifests itself with itching and the presence of rashes, which later merge into large plaques.
The disease lasts for a long time, in this case it often leads to prolonged disability, disrupts the social adaptation of patients. The diseases considered in this task are extremely diverse in medical manifestations, which can make diagnosis difficult. All of the above, without exception, confirms the need for research of this pathology by doctors of different qualifications.
The purpose of the study is to reveal the significance of this disease, the prevalence among the child population, and also paid attention to the extensive clinic of this disease and, accordingly, methods of treatment and prevention.
The task of this work is to identify and determine which of the etiological factors is the most significant in the formation of rashes, swelling and severe itching.
The main content of the study is the analysis of psoriasis and its effects on the human body.
The results achieved are that we have revealed the importance of this disease and its prevalence.

Keywords: psoriasis, immune system, disease, causes, prognosis, mortality and treatment.

References

1. Khimkina L.N. Features of the course of psoriasis in children // Vesti. dermatol.-1986.- No. 6.-P.62–66.
2. Khimkina L.N. Features of the course of psoriasis in children // Vesti. dermatol.-1986.- No. 6.-P.62–66.3. DNA repair in patients with psoriasis during therapy / A. Yu. Prokhorov, V.N.
3. Mordovtsev, G.N. Lvova, V.V. Chekhov //Vesta, dermatol.-1991.-No.1-P.4–6.
4. Psoriasis: electron microscopic, virological, molecular biological studies / V.N. Mordovtsev, I.V. Starkov, E.R. Zabarovsky et al. // News, dermatol.-1987.-No. 7.-P.4–10.
5. Vaisov A.Sh., Rakhmetov A.B., Rasuleva N.R. Sandimmune in the treatment of severe forms of psoriasis //Vesta. dermatol.-1998.-No. 6.-S.ZZ-34.
6. Belyaev G.M. Treatment and prevention of exacerbations of psoriasis, taking into account the results of studying the functional state of the pituitary-adrenal system and gonads: Abstract of thesis. dis. …Dr. med. nauk.-M., 1984.-32p.
7. Current issues of immunology in dermatology /N.M. Mazina, V.V. Vladimirov, O.N. Kuryanova, M.B. Moskalenko //Vesti. dermatol.-1993.-No.2.-P.20–25.
8. Adamenko G.P., Kozin V.M. Disturbances in the system of interaction of poly- and mononuclear phagocytes in the blood of patients with psoriasis and eczema // Pathogenesis and therapy of skin and venereal diseases: Proc. report II Congress of Dermatologists and Venereologists of the Republic of Belarus.-Minsk, 1992.-P.75
9. Andreev S.V., Semenov B.N. The importance of the skin in the mechanism of action of therapeutic media on the patient's body // Issues of balneology, physiotherapy and physical therapy culture, 1988.-№ 5.-P.59–63.
10. Vaisov A.Sh., Rakhmetov A.B., Rasuleva N.R. Sandimmune in the treatment of severe forms of psoriasis //Vesta. dermatol.-1998.-No. 6.-S.ZZ-34.